Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 11–14 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Paradoxe Intention und moderne Expositionsverfahren

Ein theoretischer Vergleich von Wirkannahmen, Vorgehen und Grenzen

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die paradoxe Intention zählt zu den bekanntesten Techniken der Logotherapie. Viktor E. Frankl beschrieb sie bereits in den 1930er- bis 1950er-Jahren als Verfahren zur Unterbrechung der Erwartungsangst bei Phobien und Zwangssymptomen. Der vorliegende Beitrag vergleicht die paradoxe Intention auf theoretischer Ebene mit gegenwärtigen Expositionsverfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere mit dem Modell der emotionalen Verarbeitung und dem Ansatz des inhibitorischen Lernens. Herausgearbeitet werden zunächst deutliche Gemeinsamkeiten: Beide Zugänge zielen auf die Aufgabe von Vermeidungs- und Kontrollverhalten, fördern die Konfrontation mit gefürchteten Erfahrungen und ermöglichen korrigierende Lernerfahrungen. Zugleich bestehen Unterschiede in der anthropologischen Begründung, in der Rolle des Humors und der Selbstdistanzierung sowie in der Strukturierung des Vorgehens. Anschließend wird diskutiert, inwieweit Konzepte wie ironische Prozesse der Gedankenkontrolle, metakognitive Modelle und kognitive Defusion als Brücken zwischen beiden Traditionen dienen können. Der Beitrag schließt mit einer Erörterung von Indikationsgrenzen und mit Vorschlägen für eine präzisere theoretische Verortung der paradoxen Intention innerhalb der gegenwärtigen Psychotherapieforschung, ohne ihre eigenständige existenzanalytische Begründung aufzugeben.

Schlüsselwörter: Paradoxe Intention · Exposition · Inhibitorisches Lernen · Selbstdistanzierung · Angststörungen

ABSTRACT

Paradoxical intention is among the best-known techniques of logotherapy. Viktor E. Frankl described it as early as the period between the 1930s and the 1950s as a method for interrupting anticipatory anxiety in phobias and obsessive-compulsive symptoms. This paper compares paradoxical intention at a theoretical level with contemporary exposure-based procedures in cognitive behavioral therapy, in particular with emotional processing theory and the inhibitory learning approach. First, substantial similarities are identified: both approaches aim at relinquishing avoidance and control behaviors, encourage confrontation with feared experiences, and enable corrective learning. At the same time, there are differences in their anthropological rationale, in the role of humor and self-distancing, and in how the procedure is structured. The paper then discusses to what extent concepts such as ironic processes of mental control, metacognitive models, and cognitive defusion may serve as bridges between the two traditions. It concludes with a discussion of the limits of indication and with suggestions for a more precise theoretical placement of paradoxical intention within current psychotherapy research, without abandoning its distinct existential-analytic foundation.

Keywords: paradoxical intention · exposure therapy · inhibitory learning · self-distancing · anxiety disorders

1 Einleitung

Unter den Techniken der Logotherapie hat die paradoxe Intention die größte Verbreitung über die eigene Schule hinaus erfahren. Frankl (1960) beschrieb sie in einem viel zitierten Aufsatz als Verfahren, bei dem Patientinnen und Patienten angeleitet werden, das Gefürchtete gerade herbeizuwünschen oder absichtlich hervorzurufen, statt es angestrengt zu vermeiden. In seiner Darstellung der Neurosenlehre hat er diesen Ansatz systematisch in ein Modell der Erwartungsangst eingebettet (Frankl, 1956).

Seither hat sich die Behandlung von Angst- und Zwangsstörungen erheblich weiterentwickelt. Expositionsbasierte Verfahren gehören heute zu den am besten untersuchten psychotherapeutischen Interventionen überhaupt (Abramowitz et al., 2019).

Es liegt daher nahe, die paradoxe Intention mit diesen Verfahren zu vergleichen. Der vorliegende Beitrag tut dies auf theoretischer Ebene. Er fragt, welche Wirkannahmen beiden Zugängen zugrunde liegen, wo sie konvergieren und wo sie sich unterscheiden.

Der Vergleich ist auch deshalb lohnend, weil die paradoxe Intention in der Literatur gelegentlich als Vorläufer verhaltenstherapeutischer Techniken bezeichnet wird. Eine solche Einordnung ist historisch nachvollziehbar, wird aber dem Selbstverständnis Frankls nur zum Teil gerecht. Es gilt daher, sowohl die funktionale Verwandtschaft als auch die eigenständige Begründung ernst zu nehmen.

2 Die paradoxe Intention im logotherapeutischen Verständnis

Frankls Ausgangspunkt ist ein zirkuläres Modell: Ein Symptom löst die Befürchtung aus, es könne wiederkehren; diese Erwartungsangst begünstigt ihrerseits das erneute Auftreten des Symptoms, was die Befürchtung weiter verstärkt (Frankl, 1956). Typische Reaktionsmuster auf diesen Zirkel sind nach Frankl die Flucht vor der Angst bei phobischen Beschwerden und der Kampf gegen die Zwangsidee bei Zwangssymptomen. Beide Muster tragen zur Verfestigung der Problematik bei.

Die paradoxe Intention setzt an dieser Stelle an. Sie fordert die betroffene Person auf, sich das Gefürchtete – etwa das Erröten, Zittern oder Schwitzen – bewusst und möglichst in übertriebener, humorvoller Form zu wünschen. Frankl (1960) betonte, dass diese Technik auf der spezifisch menschlichen Fähigkeit zur Selbstdistanzierung beruhe, die er der noetischen Dimension zurechnete. Der Humor ist dabei kein dekoratives Beiwerk, sondern ein zentrales Mittel, um Abstand vom Symptom zu gewinnen und die Angst ihrer Macht zu berauben.

Bemerkenswert ist, dass Frankl die paradoxe Intention nicht als bloße Technik verstand. Sie sollte der Person ermöglichen, sich nicht mit ihrer Angst zu identifizieren, sondern ihr gegenüber eine Haltung einzunehmen. Darin kommt die anthropologische Grundannahme der Logotherapie zum Ausdruck, dass der Mensch seinen psychischen Bedingungen nicht vollständig ausgeliefert ist, sondern zu ihnen Stellung nehmen kann.

Frankl unterschied die paradoxe Intention zudem von der Dereflexion. Während die paradoxe Intention auf die Erwartungsangst zielt, richtet sich die Dereflexion auf eine übersteigerte Selbstbeobachtung, die Frankl als Hyperreflexion bezeichnete und etwa bei Schlafstörungen und sexuellen Funktionsstörungen beschrieb (Frankl, 1956). Beiden Verfahren gemeinsam ist die Annahme, dass eine bestimmte Form angestrengter Selbstzuwendung das Problem aufrechterhält, das sie zu lösen sucht.

3 Expositionsverfahren: Von der emotionalen Verarbeitung zum inhibitorischen Lernen

Die theoretische Begründung der Exposition hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Foa und Kozak (1986) formulierten mit der Theorie der emotionalen Verarbeitung ein Modell, nach dem Angst in Gedächtnisstrukturen repräsentiert ist, die durch Aktivierung und die Aufnahme korrigierender Information verändert werden können. Habituation innerhalb und zwischen Übungssitzungen galt in diesem Modell als wichtiger Indikator gelingender Verarbeitung.

Craske et al. (2014) haben demgegenüber ein Modell des inhibitorischen Lernens vorgeschlagen. Danach wird die ursprüngliche Angstassoziation durch Exposition nicht gelöscht, sondern durch neu erlernte, hemmende Assoziationen ergänzt, die mit der ursprünglichen konkurrieren. Für die Praxis folgt daraus, dass weniger die Reduktion der Angst während der Übung als die Verletzung von Erwartungen, die Variabilität der Übungskontexte und der Verzicht auf Sicherheitsverhalten im Vordergrund stehen. Die Toleranz von Angst wird damit selbst zum Ziel.

Für die Praxis bedeutsam ist ferner, dass moderne Expositionsverfahren in der Regel auf einer sorgfältigen Fallkonzeption und einer überzeugenden Begründung beruhen, die Patientinnen und Patienten verständlich macht, warum die Konfrontation mit Angst sinnvoll ist (Abramowitz et al., 2019). Auch hier zeigt sich eine Parallele: Frankl legte Wert darauf, dass Betroffene den Mechanismus der Erwartungsangst verstehen, bevor sie die paradoxe Intention anwenden.

4 Konvergenzen

Aus der Perspektive des inhibitorischen Lernens erscheint die paradoxe Intention in neuem Licht. Indem Patientinnen und Patienten das Gefürchtete herbeiwünschen, geben sie Vermeidungs- und Kontrollstrategien auf und setzen sich der gefürchteten Erfahrung aus. Die Erwartung, dass das Symptom katastrophal eskalieren werde, wird dabei häufig nicht bestätigt. Funktional betrachtet enthält die paradoxe Intention damit zentrale Elemente einer Expositionsübung: Konfrontation, Verzicht auf Sicherheitsverhalten und Erwartungsverletzung.

Eine weitere Brücke bietet die Forschung zur Gedankenkontrolle. Wegner (1994) hat gezeigt, dass der Versuch, bestimmte Gedanken zu unterdrücken, unter bestimmten Bedingungen gerade zu deren vermehrtem Auftreten führen kann. Dieses Konzept ironischer Prozesse liefert eine experimentalpsychologisch fundierte Erklärung für die von Frankl klinisch beschriebene Beobachtung, dass der Kampf gegen ein Symptom dieses verstärken kann. Auch das metakognitive Modell von Wells (2009), das problematische Überzeugungen über die Kontrollierbarkeit und Gefährlichkeit eigener Gedanken in den Mittelpunkt stellt, weist hier Berührungspunkte auf.

Schließlich bestehen Parallelen zur kognitiven Defusion in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, bei der Gedanken als vorübergehende mentale Ereignisse betrachtet werden, statt sie als wörtliche Wahrheiten zu behandeln (Hayes et al., 2012). Manche Defusionsübungen, die mit Übertreibung, Wiederholung oder spielerischer Verfremdung arbeiten, ähneln in ihrer Struktur der humorvollen Distanzierung, die Frankl beschrieben hat.

5 Differenzen

Trotz dieser Konvergenzen wäre es verkürzend, die paradoxe Intention schlicht als frühe Form der Exposition zu deuten. Ein erster Unterschied betrifft die Begründung: Während Expositionsverfahren lern- und gedächtnispsychologisch fundiert sind, beruft sich Frankl auf eine anthropologische Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Ein zweiter Unterschied liegt in der Strukturierung. Moderne Expositionsprotokolle sind in der Regel sorgfältig geplant, mit Hierarchien, Erwartungsprüfungen und Nachbesprechungen. Die paradoxe Intention wurde dagegen häufig als kompakte, im Alltag anzuwendende Haltung vermittelt.

Ein dritter Unterschied betrifft die Rolle des Humors. In Expositionsverfahren ist Humor allenfalls ein förderlicher Kontextfaktor, in der paradoxen Intention dagegen konstitutiv. Ob und in welchem Maße Humor selbst zur Wirksamkeit beiträgt, ist eine offene empirische Frage. Hinzu kommt, dass paradoxe Interventionen in der Literatur unter sehr unterschiedlichen Bezeichnungen und Verfahrensweisen untersucht wurden. Eine frühe Meta-Analyse paradoxer Interventionen (Shoham-Salomon & Rosenthal, 1987) deutet zwar auf eine gewisse Wirksamkeit hin, verweist aber zugleich auf erhebliche Heterogenität, sodass Rückschlüsse auf die logotherapeutische Technik im engeren Sinn nur vorsichtig gezogen werden können.

Ein vierter Unterschied betrifft das Ziel. Expositionsverfahren richten sich primär auf die Reduktion von Angst und Vermeidung bzw. auf eine verbesserte Angsttoleranz. Für Frankl war die Überwindung der Erwartungsangst dagegen kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, dass sich die Person wieder den Aufgaben und Werten ihres Lebens zuwenden kann. In dieser Hinsicht steht die paradoxe Intention der Akzeptanz- und Commitment-Therapie nahe, die Angstreduktion ebenfalls nicht als primäres Ziel betrachtet, sondern wertorientiertes Handeln in den Mittelpunkt stellt (Hayes et al., 2012).

6 Indikationsgrenzen und Ausblick

Bereits Frankl (1956) hat darauf hingewiesen, dass die paradoxe Intention nicht bei allen Beschwerdebildern angezeigt ist. Bei depressiven Zuständen mit Suizidalität etwa wäre eine Aufforderung, das Gefürchtete herbeizuwünschen, offenkundig kontraindiziert. Auch bei Zwangsgedanken mit aggressivem Inhalt bedarf es sorgfältiger Psychoedukation, damit die Technik nicht als Bagatellisierung erlebt wird. Ein tragfähiges Arbeitsbündnis und eine klare Begründung der Intervention sind daher unverzichtbar.

Für die künftige Forschung bietet das Modell des inhibitorischen Lernens einen Rahmen, in dem sich Hypothesen über die Wirkweise der paradoxen Intention präzise formulieren lassen, etwa zur Rolle der Erwartungsverletzung oder zum Beitrag von Humor und Selbstdistanzierung. Eine solche Integration würde die paradoxe Intention nicht ihrer existenzanalytischen Begründung berauben, sondern diese um eine anschlussfähige Mechanismusperspektive ergänzen.

Methodisch bieten sich für die Prüfung solcher Hypothesen Komponentenanalysen an, in denen etwa eine Expositionsbedingung mit und ohne humorvoll-paradoxe Instruktion verglichen wird. Auf diese Weise ließe sich klären, ob die paradoxe Formulierung über die Konfrontation hinaus einen eigenständigen Beitrag leistet. Ebenso wäre zu untersuchen, ob Personen mit ausgeprägter Neigung zur Gedankenunterdrückung oder mit metakognitiven Überzeugungen über die Gefährlichkeit eigener Gedanken besonders von einer paradoxen Haltung profitieren (Wegner, 1994; Wells, 2009).

Literatur

Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). Exposure therapy for anxiety: Principles and practice (2nd ed.). Guilford Press.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35.

Frankl, V. E. (1956). Theorie und Therapie der Neurosen: Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse. Urban & Schwarzenberg.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Shoham-Salomon, V., & Rosenthal, R. (1987). Paradoxical interventions: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 22–28.

Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101(1), 34–52.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). Paradoxical Intention and Modern Exposure Procedures: A Theoretical Comparison of Assumed Mechanisms, Procedure, and Limitations. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 11–14.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.